תוכנית מעקב טרום-קלינית

להגן על ההווה,
להכין את העתיד

תוכנית מעקב עבור נשאים ללא תסמינים של מוטציות בגן של חלבון הפריון

להחזיק במידע על הגנטיקה שלך הוא מעשה של אומץ. אתר זה נועד ללוות אותך: להסביר לך מה משמעות הדבר להיות נשא או נשאית, מדוע מעקב תקופתי הוא כלי יעיל, ואילו אפשרויות מציע העתיד הקרוב

01 להבין את נקודת ההתחלה שלך

מה משמעות הדבר להיות נשא או נשאית

אתה נשא או נשאית של וריאנט גנטי (הנקרא גם מוטציה – שינוי ב-DNA ביחס לרוב האוכלוסייה) שעשוי להיות קשור בהתפתחות מחלת פריונים תורשתית. משמעות הדבר שקיים סיכון מוגבר, לא ודאות. אנשים רבים עם נטייה גנטית זו חיים עשורים מבלי לפתח תסמין כלשהו, והמדע מתקדם בקצב מהיר לעבר טיפולים מונעים.

להיות נשא או נשאית אין פירושו כמו לחלות במחלה. זוהי נטייה המעניקה לך מידע יקר ערך – ומידע זה יכול, בשימוש נכון, להפוך ליתרון ממשי.

- **לא כל הנשאים מפתחים תסמינים.** החדירות – כלומר ההסתברות שהמוטציה תגרום בסופו של דבר למחלה – גבוהה, אם כי גיל ההופעה משתנה באופן ניכר בהתאם למוטציה הספציפית ולגורמים אישיים נוספים שעדיין איננו מכירים.

- **ידע הוא כוח.** הכרת מצבך הגנטי מאפשרת לך לקבל החלטות מושכלות, לתכנן את העתיד ולגשת לתוכניות מעקב מתמחות.

- **המדע אינו עוצר.** מעולם לא היה כה הרבה מחקר פעיל על מחלות פריונים כמו היום. אנו נמצאים ברגע מכריע לפיתוח טיפולים מונעים.

02

מדוע המעקב חשוב

ארבע סיבות להשתתף בתוכנית מעקב טרום-קלינית

תוכניות המעקב עבור נשאים ללא תסמינים אינן רק כלי מחקר ופיקוח רפואי. הן מהוות פלטפורמה של היערכות פעילה – עבורך ועבור כל האנשים שיבואו אחריך – לנוכח הטיפולים המונעים שבפיתוח.

זיהוי מוקדם

זיהוי מוקדם: אם יופיעו שינויים ביולוגיים עדינים, הם יזוהו ברגע המיטבי ביותר (בטרם הופעת התסמינים) כדי לאפשר התערבות באמצעים הזמינים.

גישה בעדיפות

גישה בעדיפות: המשתתפים בתוכניות המעקב יהיו במיקום הטוב ביותר לגשת לטיפולים מונעים חדשים כאשר הניסויים הקליניים יפתחו את שעריהם, משום שיהיה עליהם יותר מידע מאשר על נשאים אחרים.

מידע אמיתי

המעקב התקופתי מספק נתונים אובייקטיביים על בריאות מוחך ומחליף את אי-הוודאות בידע מבוסס. זהו מידע שאתה יכול לגשת אליו או שאולי עדיין אינך רוצה לדעת.

תרומה קולקטיבית

השתתפותך מסייעת להבין טוב יותר את המחלה ומאיצה את פיתוח הטיפולים עבורך ועבור הדורות הבאים.

03

שתי מציאויות בתוך אותו פרופיל

לא כל הנשאים ללא תסמינים נמצאים באותו רגע

בתוך קבוצת הנשאים ללא תסמינים, המחקר הנוכחי מאפשר לזהות שני מצבים שונים בבירור, אף שבשני המקרים האדם אינו מציג תסמינים קליניים:

נשא/נשאית בשלב הלא-פעיל

התהליך הביולוגי הקשור במוטציה אינו מראה סימנים של פעילות ניתנת לזיהוי בטכניקות הנוכחיות. דבר זה קשור באופק זמן רחב יותר בטרם הופעה אפשרית של התסמינים הראשונים.

נשא/נשאית בשלב הפעיל השקט

קיימת פעילות ביולוגית מתהווה –ללא תסמינים קליניים– שטכניקות מתקדמות יכולות להתחיל לזהות. פרופיל זה קשור באופק זמן קרוב יותר, אם כי עדיין איננו יודעים בכמה ואם קיימת שונות גדולה בין נשאים, מזיהוי הפעילות הביולוגית ועד להתפתחות הסימנים הראשונים. עם זאת, לקבוצה זו ההסתברות הגבוהה ביותר לגשת לניסויים הקליניים המונעים הראשונים.

לגלות באיזה מהמצבים הללו אתה נמצא הוא דבר וולונטרי. תוכנית המעקב מציעה לך את האפשרות לדעת זאת – תמיד בליווי וללא לחץ.

04

מה שמצטייר באופק

טיפולים בפיתוח וניסויים קליניים ראשונים

מעולם לא היו כה הרבה אסטרטגיות טיפוליות פעילות בו-זמנית למחלות פריונים. כמה מהן כבר הראו תוצאות מבטיחות במודלים של בעלי חיים, וחלקן החלו לעשות את הקפיצה לניסויים בבני אדם. אין זה מבטיח שכולן יפעלו בבני אדם, אך זה מסמן שינוי היסטורי: בפעם הראשונה קיימות כמה דרכים ממשיות הפועלות במקביל לעבר טיפולים מונעים וטיפולים מעכבי מחלה עתידיים.

מה משמעות כל מצב

ניסוי קליני בעיצומו

כבר נבדק בבני אדם.

ניסוי קליני רשום, בהמתנה להתחלה

הניסוי מוגדר ומאושר/רשום, אך עדיין לא החל בגיוס או בטיפול.

פיתוח טרום-קליני

הטיפול הראה פעילות במעבדה ו/או בבעלי חיים, אך עדיין לא נבדק בבני אדם.

ניסוי קליני בעיצומו (שלב 1/2a)

אוליגונוקלאוטידים אנטי-סנס (ASO)

אלה מולקולות שפותחו כדי להפחית את ייצור חלבון הפריון. במודלים של בעלי חיים, הפחתת חלבון זה עיכבה את הופעת המחלה והאריכה את ההישרדות. אסטרטגיה זו כבר מוערכת בניסוי קליני בינלאומי בבני אדם עם מחלת פריונים סימפטומטית.

ניסוי קליני רשום, בהמתנה להתחלה (שלב 1)

הפרעת RNA (siRNA)

מולקולות אלה "משתיקות" את המסר הגנטי המוביל לחלבון הפריון. בבעלי חיים הושגו הפחתות עמוקות ומתמשכות של חלבון זה, עם השפעות חיוביות על מהלך המחלה. כמו כן, כבר קיים ניסוי קליני ראשון של שלב 1 הרשום עבור אסטרטגיה זו, אם כי הגיוס עדיין לא החל.

פיתוח טרום-קליני

מולקולות קטנות למתן דרך הפה

מפתחים תרכובות המסוגלות להפחית את כמות חלבון הפריון שהתא מייצר. יתרונן הפוטנציאלי הגדול הוא שניתן יהיה לתת אותן כטיפולים פשוטים לטווח ארוך. הנתונים שפורסמו עד כה מראים תוצאות מבטיחות בבעלי חיים, אך דרך זו עדיין לא עברה לניסויים קליניים.

פיתוח טרום-קליני

טיפולים גניים

הם כוללים אסטרטגיות של השתקה קבועה ועריכה מולקולרית שנועדו לכבות או להפחית לצמיתות את הגן של חלבון הפריון. במודלים של בעלי חיים כבר הושגו הפחתה רחבה של החלבון והארכה משמעותית של ההישרדות. כמה תוכניות מתקדמות לעבר הקליניקה, אך כרגע הן עדיין בשלב הטרום-קליני.

להיות רשום בתוכנית מעקב מציב אותך בחזית להשתתף בניסויים אלה, אם יתקיימו בספרד. חלון ההזדמנויות נפתח — ומי שכבר במעקב יהיו בעלי הסיכוי הגבוה ביותר לעבור דרכו ראשונים.

05

מה כולל המעקב

פרוטוקול הביקורים התקופתיים

התוכנית מורכבת מביקורים תקופתיים – בדרך כלל שנתיים או חצי-שנתיים – במרכז מתמחה. כל ביקור מתוכנן להיות נוח ויעיל ככל האפשר, תמיד בתמיכת צוות ייעודי.

הערכה נוירולוגית ונוירופסיכולוגית

בדיקה קלינית מפורטת ומערך מבחנים קוגניטיביים לקביעת ומעקב אחר ערך הבסיס האישי שלך.

סמנים ביולוגיים בדם, בנוזל השדרה ובעור

בדיקת דם, ובמקרה הצורך ניקור מותני ו/או ביופסיית עור בניקוב למדידת חלבונים ספציפיים המשקפים את המצב הנוירוביולוגי.

בדיקת שינה

באמצעות פוליסומנוגרפיה אנו רושמים את המתרחש במהלך השינה: תנועות, נשימה, פעילות מוחית והתנהגות. הפרעות שינה מסוימות – בייחוד אלה הקשורות בשלב ה-REM – עשויות להופיע באופן עדין, בייחוד אצל נשאי נדודי שינה משפחתיים קטלניים, בטרם יופיעו התסמינים הראשונים.

הדמיה ברזולוציה גבוהה

הדמיית תהודה מגנטית של המוח, המאפשרת לזהות שינויים מבניים או תפקודיים בטרם יהיו ניתנים לזיהוי קליני.

תמיכה פסיכולוגית

ליווי רגשי והכוונה מקצועית, זמינים בכל ביקור ונגישים בין ביקור לביקור בעת הצורך.

מידע על חידושים טיפוליים

עדכון תקופתי על ניסויים קליניים זמינים או בהכנה שעבורם אתה עשוי להיות מתאים, עם הכוונה מותאמת אישית לכל הזדמנות.